

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004828-08.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA LUIZA LOPES FORSTER

RECORRIDO: ANDRE DA SILVA RAMOS

MEDIDA DE URGÊNCIA. IRECURSO INTERPOSTO PELA UNIÃO. INSULINA. NAT CONFIRMA A NECESSIDADE E URGÊNCIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E DISPONÍVEL PELO SUS, PORÉM AINDA NÃO ADQUIRIDO PARA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, baixem os autos e arquivem os mesmos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5004828-08.2025.4.02.5101

510015514193 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004828-08.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA LUIZA LOPES FORSTER

RECORRIDO: ANDRE DA SILVA RAMOS

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União, em face da decisão do Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

*"Por estas razões, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar que os réus forneçam a autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) a medicação **INSULINA DEGLUDECA**, conforme posologia indicada no laudo do Evento 1, ANEXO2, fl. 22, em quantidade suficiente a garantir, no mínimo o tratamento da autora pelo prazo de 90 dias. Fornecida a dosagem mensal inicial, os réus deverão fornecer, na data e local definidos, mensalmente, a dosagem mensal mínima, mediante apresentação de receituário médico atualizado pelo autor."*

Alega a recorrente a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Alega ainda que mera declaração de hipossuficiência não ser comprovação da incapacidade de custear o próprio tratamento e que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em caso da manutenção da tutela, requer o redirecionamento da decisão ao ente federado competente.

Decisão do evento 4, indeferiu a liminar.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 4. Ressalta-se não ser o caso de aplicação do Tema 1234 do STF, tendo em vista que o NAT informou que o medicamento é registrado na ANVISA e que a NOTA TÉCNICA Nº 1467/2023-COMFAD/CGPJUD/DJUD/SE/MS inform que o medicamento pretendido foi incorporada ao Sistema Único de Saúde - SUS, no entanto ainda não adquirido.

Trata-se de demanda originária ajuizada por MARIA LUIZA LOPES FORSTER em face da **UNIÃO**, do **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO** e do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, objetivando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Insulina Degludeca 100U/mL (Tresiba®) -18U/dia (Evento 1_ANEXO2, páginas 15 a 21).

O NAT, em seu parecer, informou que a parte autora foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em outubro de 2021 e que já utilizou insulina NPH. Informa que a mesma apresenta labilidade em glicemia com períodos de hiperglicemia e hipoglicemia, sendo prescrito, em uso contínuo, o medicamento Insulina Degludeca 100U/mL (Tresiba®) -18U/dia (Evento 1_ANEXO2, páginas 15 a 21).

De acordo com o NAT o medicamento Insulina Degludeca 100U/mL (Tresiba®) está indicado em bula para o manejo do quadro clínico apresentado pela Autora - diabetes mellitus tipo 1 e que o medicamento tem registro na ANVISA.

Quanto a disponibilização, assim informou:

"(...)No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado insta mencionar que as insulinas análogas de ação prolongada (grupo da insulina pleiteada Degludeca) foram incorporados ao SUS para o tratamento do diabetes mellitus tipo I2 , conforme Tabela Unificada do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP3 : insulina análoga de ação prolongada 100UI/mL (06.04.78.005-2) e Insulina análoga de ação prolongada 100UI/mL (06.04.78.006-0) perfazendo o grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF): medicamento financiado pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal^{4,5} . Os critérios de acesso foram definidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT6) do Ministério da Saúde para o tratamento do referido quadro clínico, segundo Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019.

➤ Contudo, o medicamento Insulina Degludeca 100U/mL (Tresiba®) ainda não integra⁷ , uma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro (...)"

Observa-se dos autos originários que a Coordenação de Análise Médica e Farmacêutica de Demandas Judiciais em Saúde apresentou NOTA TÉCNICA Nº 1467/2023-COMFAD/CGPJUD/DJUD/SE/MS, informando que o medicamento em questão foi incorporada ao Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com a Portaria nº 19, de 27 de março de 2019, e será disponibilizado por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF. No entanto, informou que o Ministério da Saúde está realizando os trâmites licitatórios para aquisição do fármaco (fase interna), e, tão logo o processo aquisitivo seja finalizado, o medicamento em tela será disponibilizado às Secretarias Estaduais de Saúde, para o tratamento dos pacientes que estiverem de acordo com os critérios estabelecido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, publicado por intermédio da Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 17 - 12 de novembro de 2019 (Publicada em 13/11/2019).

Assim, verifica-se que o medicamento é fornecido pelo SUS, mas ainda não foi adquirido para distribuição.

Nesse sentido, tendo o NAT informado que a parte autora já utilizou o medicamento insulina NPH, que atualmente esta sendo fornecido pelo SUS, sem sucesso, não resta outra alternativa ao fornecimento do medicamento em questão, devendo ser mantida tutela de urgência concedida.

Quando ao direcionamento, em razão de a aquisição do medicamento ainda estar fase de licitação, sendo de responsabilidade do Ministério da Saúde a compra do mesmo, entendo que o cumprimento deve ser direcionado inicialmente à União, em prejuízo de posterior ressarcimento pelos outros réus a ser verificada na fase de execução.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, baixem os autos e arquivem os mesmos.